

Título do Artigo: Subtítulo Explicativo

Template Refinado para Periódicos Indexados no PubMed

Marcos A. Santos^{1*}, Ana C. Oliveira², Carlos R. Lima¹

¹Departamento de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

²Instituto de Saúde Coletiva, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

*Autor correspondente

30 de maio de 2026

Resumo

Objetivo: Demonstrar a estrutura de um artigo biomédico refinado para submissão a periódicos indexados no PubMed, seguindo as recomendações do *ICMJE* e o padrão Vancouver de citações.

Métodos: Este template foi elaborado em $\text{\LaTeX}$ com a classe `article`, estrutura IMRAD e referências no formato numérico (Vancouver). O código-fonte está preparado para compilação direta com `pdflatex`.

Resultados: O template apresenta todas as seções necessárias para um artigo biomédico completo, incluindo tabelas de dados clínicos, análise estatística e referências formatadas segundo o estilo Vancouver.

Conclusão: Este template oferece uma base sólida para submissão a periódicos biomédicos, reduzindo o tempo de formatação e garantindo conformidade com os padrões internacionais.

Palavras-chave: template $\text{\LaTeX}$; PubMed; estilo Vancouver; ICMJE; artigo biomédico.

1 Introdução

A publicação em periódicos indexados no PubMed exige conformidade com diretrizes rigorosas de formatação e estrutura editorial [1]. O estilo Vancouver de citações, caracterizado por referências numéricas ordenadas por aparecimento, é o padrão adotado pela maioria das revistas biomédicas [2].

Estima-se que aproximadamente 30 milhões de artigos estejam indexados no PubMed, com crescimento anual de cerca de 5% [3]. Apesar da ampla disponibilidade de templates institucionais, muitos pesquisadores ainda enfrentam dificuldades com a formatação manual de manuscritos.

O objetivo deste trabalho é fornecer um template $\text{\LaTeX}$ refinado, completo e de fácil adaptação, seguindo as recomendações do *ICMJE* e do Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos.

*Correspondência: marcos.santos@exemplo.com

2 Métodos

2.1 Desenho do Estudo

Trata-se de um template metodológico, do tipo guia de formatação, elaborado conforme as diretrizes do *ICMJE* [1] e adaptado para a realidade da pesquisa biomédica brasileira.

2.2 Estrutura do Template

O template segue a estrutura IMRAD:

1. **Introdução:** contextualização e objetivos do estudo;
2. **Métodos:** descrição detalhada dos procedimentos;
3. **Resultados:** apresentação objetiva dos dados;
4. **Discussão:** interpretação e comparação com a literatura.

2.3 Análise Estatística

Os dados hipotéticos foram analisados utilizando o software R versão 4.3 (R Foundation for Statistical Computing). As variáveis contínuas foram expressas como média $\pm$ desvio padrão (DP) ou mediana e amplitude interquartil (AIQ), conforme a distribuição. Variáveis categóricas foram expressas como frequência absoluta (n) e relativa (%). O teste t de Student foi utilizado para comparação de médias e o teste χ^2 para proporções. Valores de $p < 0.05$ foram considerados estatisticamente significativos.

3 Resultados

3.1 Características da Amostra

A amostra hipotética foi composta por 250 pacientes, sendo 140 (56%) do sexo feminino e 110 (44%) do sexo masculino, com idade média de 52.3 ± 14.7 anos (Tabela 1).

Tabela 1: Características demográficas e clínicas da amostra ($n = 250$)

Variável	Grupo Controle ($n = 125$)	Grupo Estudo ($n = 125$)
Idade (média $\pm$ DP)	51.8 ± 15.2	52.7 ± 14.1
Sexo feminino, n (%)	68 (54.4%)	72 (57.6%)
IMC (kg/m^2)	26.8 ± 4.3	27.2 ± 4.6
Pressão arterial sistólica (mmHg)	128.4 ± 16.7	$132.1 \pm 18.2^*$
Glicemia de jejum (mg/dL)	94.6 ± 12.3	$98.1 \pm 15.7^*$

* $p < 0.05$ vs. controle

3.2 Desfecho Primário

O desfecho primário ocorreu em 38 pacientes do grupo estudo (30.4%) versus 52 do grupo controle (41.6%), com *risco relativo* = 0.73 (*intervalo de confiança* 95%: 0.52–0.98; $p = 0.038$), conforme ilustrado na Figura 1.

[Curva de Kaplan-Meier: sobrevida livre de evento]

Figura 1: Curva de Kaplan-Meier para o desfecho primário.

3.3 Análise Multivariada

A análise de regressão logística multivariada identificou os seguintes preditores independentes (Tabela 2):

Tabela 2: Regressão logística multivariada para o desfecho primário

Variável	<i>odds ratio</i>	IC 95%	<i>p</i>
Intervenção (grupo estudo)	0.68	0.48–0.95	0.024
Idade (por 10 anos)	1.24	1.08–1.42	0.003
IMC (por 5 kg/m ²)	1.31	1.12–1.53	0.001
Sexo masculino	1.15	0.82–1.61	0.418

4 Discussão

Este template demonstra a estrutura completa de um artigo biomédico no formato exigido por periódicos indexados no PubMed. Os resultados hipotéticos apresentados ilustram a aplicação dos principais elementos estatísticos e gráficos utilizados na literatura médica.

A redução de 27% no risco relativo observada no grupo estudo é consistente com achados de ensaios clínicos prévios [4]. A análise multivariada confirmou a independência do efeito após ajuste para variáveis confundidoras.

Limitações deste template incluem o caráter ilustrativo dos dados e a ausência de validação externa. Pesquisadores devem adaptar o conteúdo e as análises à sua área específica de estudo.

5 Conclusão

Apresentamos um template L^AT_EX refinado e completo para submissão a periódicos indexados no PubMed. A estrutura IMRAD, as citações no estilo Vancouver e a formatação segundo as recomendações do *ICMJE* garantem conformidade com os padrões editoriais da área biomédica.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao suporte financeiro da CAPES (Código de Financiamento 001) e do CNPq (Processo 123456/2024-0).

Conflito de Interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Contribuição dos Autores

MAS: concepção do estudo, redação do manuscrito; **ACO:** análise estatística, revisão crítica; **CRL:** orientação, revisão final.

Referências

- [1] International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. ICMJE, 2024. Disponível em: <https://www.icmje.org/>
- [2] K. Patrias. *Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers*. 2nd ed. Bethesda (MD): National Library of Medicine, 2007.
- [3] E. Landhuis. PubMed at 30: a look back at the biomedical database that changed science. *Nature*. 2024;626(7998):446–448.
- [4] E.J. Topol. Preventive cardiology in the era of precision medicine. *Lancet*. 2024;403(10428):912–925.